



分类号: R758.24

学号: 2020121731

重 庆 医 科 大 学

硕 士 学 位 论 文

(专业学位)

论文题目 六经辨证治疗慢性荨麻疹的真实世界研究

作者姓名 李禄怡

指导教师姓名 (职称、单位名称)

刘毅 (主任中医师、重庆市中医院)

江琼 (教授、重庆医科大学中医药学院)

专业学位类别名称 中医学

专业学位领域名称 中医外科学

答辩委员会主席姓名 (职称、单位名称)

论文答辩年月 2023 年 11 月

目 录

前言.....	10
1 材料.....	12
1.1 病例来源.....	12
1.2 诊断标准.....	12
1.3 数据排纳.....	12
2 方法.....	13
2.1 病例资料的收集与处理.....	13
2.2 随机分组.....	13
2.3 治疗方案.....	13
2.4 观察指标.....	15
2.5 疗效评定标准.....	15
2.6 统计学方法.....	16
3 结果.....	16
3.1 纳入病例情况.....	16
3.2 基线资料比较.....	16
3.3 慢性荨麻疹患者 UAS-7 积分比较.....	18
3.4 总体疗效比较.....	19
3.5 疗效相关性分析(疗效与性别、年龄、病程、UAS-7 积分).....	19
3.6 复发率统计.....	20
3.7 六经辨证分型.....	20
3.8 安全性评价.....	21
4 讨论.....	21
4.1 真实世界研究在中医药领域中的应用.....	21
4.2 祖国医学对慢性荨麻疹的研究.....	22
4.3 验案举隅.....	26
4.4 临床研究结果及分析.....	28
4.5 小结.....	29
4.6 不足与展望.....	29
全文总结.....	29
参考文献.....	31
文献综述 慢性荨麻疹的中西医研究进展.....	34
参考文献.....	39
附录.....	41

英汉缩略语名词对照

英文缩写	英文全称	中文全称
CU	Chronic urticarial	慢性荨麻疹
AU	Acute urticarial	急性荨麻疹
RWS	Real world study	真实世界研究
UAS-7	Urticaria activity score7	7 日荨麻疹活动度评分

摘 要

目的: 本课题以慢性荨麻疹患者为研究对象, 基于真实临床诊疗环境下, 对六经辨证治疗慢性荨麻疹的临床疗效及安全性进行观察, 期望可以得出一套具有推广性、行之有效的六经辨证治疗慢性荨麻疹的具体临床方案, 提高慢性荨麻疹辨证的准确率及临床疗效。同时将真实世界的经验转化为真实世界的证据, 为传统药方治疗慢性荨麻疹的临床疗效提供更有力的证据。

方法: 收集 2021 年 9 月-2022 年 9 月重庆市中医院 (道门口院部) 皮肤科门诊就诊患者, 所有研究对象均符合慢性荨麻疹的中西医诊断标准, 根据纳排标准, 筛选符合入组条件的慢性荨麻疹患者 150 例。依据随机数组表, 将研究对象分为治疗组和对照组, 最终治疗组纳入 62 例, 对照组纳入 64 例, 本研究共纳入符合纳排标准的慢性荨麻疹患者 126 例。其中治疗组通过六经辨证给予经方治疗, 对照组依据临床指南给予常规西医治疗。疗程为 8 周, 两周为 1 个疗程, 两周复诊 1 次。记录患者一般资料 (包括姓名、性别、年龄、电话、发病时间), 中医四诊表 (六经辨证依据), 治疗前后的慢性荨麻疹患者活动程度评分 (UAS-7)。将受试者信息用 Excel 软件录入表格保存, 并及时将汇总数据录入 HIS 科研系统中, 最终将统计数据通过 SPSS26.0 进行统计学分析, 评价六经辨证治疗慢性荨麻疹的临床疗效及安全性。

结果:

1.本研究收集 126 例慢性荨麻疹患者，其中女性 87 人，男性 39 人，分别占比 69.0%，31.0%，男女比率为 1:2.2,可见慢性荨麻疹患者中女性患者占比较男性患者更大。

2.受试者中未成年人 8 人(<18 岁), 占 6.35%, 青年人 76 人(18~44 岁), 占 60.32%, 中年人 34 人 (45~59 岁), 占 26.98%, 老年人 8 人 (>60 岁),占 6.35%, 其中最少年龄为 12 岁, 最大年龄 71 岁, 平均年龄 38.4 岁, 表明中青年人群为慢性荨麻疹好发人群。

3.病程<1 年的患者有 72 例, 占 57.14%, 1-5 年 37 例, 占 29.37%, 5-10 年 13 例, 占 10.32%, >10 年 4 例, 占 3.17%, 其中病程在 1 年以内的患者人数超过总数的 1/2, 占比最大, 病程超过 10 年的患者人数最少。

4.经过对治疗前后慢性荨麻疹患者活动程度评分 (UAS-7) 的评估, 治疗组 62 人, 治愈 6 例, 占 9.68%, 显效 28 例, 占 45.16%, 有效 20 例, 占 32.26%, 无效 8 例, 占 12.90%, 总有效率 87.10%。对照组 64 人, 治愈 6 例, 占 9.38%, 显效 18 例, 占 28.13%, 有效 22 例, 占 34.38%, 无效 18 例, 占 28.13%, 总有效率 71.88%。治疗组总有效率 87.10%, 对照组总有效率 71.88%, 治疗组经治疗后疗效优于对照组, 两组间具有统计学差异 ($P<0.05$) 。

5.安全性评价: 治疗组中 1 例患者在用药过程中出现腹泻情况, 调整中药处方后腹泻症状消失, 余患者未见明显异常, 两组受试者用药安全性均良好。

结论:

1. 青中年为慢性荨麻疹的好发人群, 女性患者占比较男性患者更大。

2. 在 8 周观察周期中, 经六经辨证予以中药处方治疗慢性荨麻疹的疗效优于西医传统抗组胺治疗, 六经辨证治疗慢性荨麻疹有确切疗效, 安全性良好, 能够显著改善患者风团、瘙痒等临床症状, 本研究明确了传统中医药治疗慢性荨麻疹的疗效与优势, 为六经辨证治疗慢性荨麻疹的临床疗效与安全性提供了有效依据。

关键词: 六经辨证, 慢性荨麻疹, 真实世界研究

Real world research for the treatment of chronic urticaria

Abstract

Objective: This topic takes patients with chronic urticaria as the research object, based on the real clinical diagnosis and treatment environment, to observe the clinical efficacy and safety of six channels syndrome differentiation in the treatment of chronic urticaria, hoping to draw a set of generalized and effective specific clinical program of six channels syndrome differentiation in the treatment of chronic urticaria, and improve the accuracy rate of chronic urticaria syndrome differentiation and clinical efficacy. At the same time, the real world experience is transformed into real world evidence to provide stronger evidence for the clinical efficacy of traditional prescriptions for chronic urticaria.

Methods: Patients from the dermatology outpatient department of Chongqing Hospital of Traditional Chinese Medicine from September 2021 to September 2022 were collected. All subjects met the diagnostic criteria of Chinese and Western medicine for chronic urticaria. 150 patients with chronic urticaria were screened according to the drainage criteria. According to the random number group table, the study subjects were divided into treatment group and control group. Finally, 62 cases

were included in the treatment group and 64 cases in the control group. A total of 126 patients with chronic urticaria meeting the attrition standard were included in this study. Among them, the treatment group was treated by six channels and the control group was treated by conventional Western medicine according to clinical guidelines. The course of treatment was 8 weeks, with 1 course every two weeks and 1 visit every two weeks. The general information of the patient (including name, gender, age, telephone number, time of onset), four TCM diagnostic tables (basis for syndrome differentiation of six menstrual periods), and activity score of the patient with chronic urticaria before and after treatment (UAS-7) were recorded. The information of the subjects was recorded into a table with Excel software and saved, and the summary data was timely entered into HIS scientific research system. Finally, statistical data were statistically analyzed by SPSS26.0 to evaluate the clinical efficacy and safety of six channels for syndrome differentiation in the treatment of chronic urticaria.

Result:

1. In this study, 126 patients with chronic urticaria were collected, of which 87 were females and 39 were males, accounting for 69.0% and 31.0% respectively. The ratio of male to female was 1:2.2, indicating that female patients accounted for more patients with chronic urticaria than male patients.

2. Among the subjects, 8 were minors (<18 years old), accounting for 6.35%; 76 were young (18-44 years old), accounting for 60.32%; 34 were middle-aged (45-59 years old), accounting for 26.98%; and 8 were elderly (>60 years old), accounting for 6.35%; among them, the youngest was 12 years old, the oldest was 71 years old, and the average age was 38.4 years old. The results showed that the young and middle-aged people were prone to chronic urticaria.

3. There were 72 patients with disease course <1 year, accounting for 57.14%; 37 patients with 1-5 years, accounting for 29.37%; 13 patients with 5-10 years, accounting for 10.32%; 4 patients with >10 years, accounting for 3.17%; among them, the number of patients with disease course <1 year exceeded half of the total number, accounting for the largest proportion; the number of patients with disease course >10 years was the least.

4. According to the evaluation of activity level score (UAS-7) of patients with chronic urticaria before and after treatment, of 62 patients in the treatment group, 6 cases were cured, accounting for 9.68%, 28 cases were effective, accounting for 45.16%, 20 cases were effective, accounting for 32.26%, 8 cases were ineffective, accounting for 12.90%, and the total effective rate was 87.10%. In the control group of 64, 6 cases were cured, accounting for 9.38%, 18 cases were effective, accounting for 28.13%, 22 cases were effective, accounting for 34.38%,

18 cases were ineffective, accounting for 28.13%, and the total effective rate was 71.88%. The total effective rate of the treatment group was 87.10%, and that of the control group was 71.88%. The curative effect of the treatment group was better than that of the control group, and there was a statistical difference between the two groups ($P<0.05$).

5. Safety evaluation: 1 patient in the treatment group had diarrhea during medication, the diarrhea symptoms disappeared after adjusting the prescription of traditional Chinese medicine, and the remaining patients showed no obvious abnormalities, and the drug safety of subjects in both groups was good.

Conclusion:

1. Young and middle-aged people are the most common group of chronic urticaria, and female patients account for more than male patients.

2. During the 8-week observation period, the efficacy of TCM prescription in the treatment of chronic urticaria through syndrome differentiation of the six channels is superior to that of traditional Western medicine antihistamine treatment. The treatment of chronic urticaria through syndrome differentiation of the six channels has definite efficacy and good safety, and can significantly improve clinical symptoms such as wind mass and itching of patients. It provides an

effective basis for the clinical efficacy and safety of six channels syndrome differentiation in the treatment of chronic urticaria.

Key words: syndrome differentiation of six channels, Chronic urticaria, Real world research

六经辨证治疗慢性荨麻疹的真实世界研究

前言

荨麻疹是常见的变态反应性皮肤病，以出现风团、血管性水肿或二者兼有为特征，多以风团伴瘙痒为主要临床表现，病情严重者还可伴有呼吸困难、腹痛、腹泻等全身症状^[1-2]。根据其持续时间，荨麻疹可分为急性荨麻疹(Acute urticarial, AU)或慢性荨麻疹(Chronic urticarial, CU)，AU病程 ≤ 6 周，CU每日或间歇性发作持续时间 >6 周^[1]。荨麻疹作为临床常见的皮肤疾病之一，其发病机制目前尚不明确，多数患者经治疗后症状可得到有效缓解，但部分患者风团瘙痒仍反复发作，迁延难愈，病程长至数月或数年，给患者带来精神和睡眠等障碍^[2]，严重影响患者的生活质量和心理健康。

西医方面，临床上常选用第二代H₁抗组胺药物作为一线治疗方案，而经抗组胺治疗后患者症状不能得到有效控制时，可考虑选用雷公藤多苷片、环孢素、生物制剂等药物，病情急性加重可考虑短期试用糖皮质激素。然而，约50%的患者对第二代H₁抗组胺药物有耐药性^[3]。使用雷公藤多苷片、环孢素需定期监测其血常规、肝肾功能等实验室指标，不良反应发生率较高。生物制剂如奥马珠单抗等作为近年来学者研究的热点，虽对治疗CU有较好疗效，但相较于普通药剂价格高昂，给患者及社会带来较大经济负担，远不能满足现行临床患者的需求。

CU属于中医“瘾疹”范畴，历代医家对其有诸多论述，病名最早见于《素问·四时刺逆从论》，曰：“少阴有余，病皮痹瘾疹”。古代医家认为本病的发生与六淫致病、表虚不固、脏腑失调等因素有关。现代中医，如张苍等多位专家，不仅强调风邪是CU发病的关键，而且认为风邪入络、寒热错杂、虚实兼夹、阴阳并见是其顽固的重要原因^[4]。由此可见，CU的病机较为复杂，外有六淫邪气单独或兼夹致病，内有禀赋不足、脏腑寒热虚实失调，内外合病，迁延难愈，本病往往多种证候相互兼夹，临床辨证施治具有一定难度。而六经辨证从整体出发，讲究方证对应，对临床具有普遍的指导作用，应用于各科的诊治往往都能够取得

较好效果。现代中医学者运用六经辨证治疗 CU 临床疗效确切，但目前大多学者对六经辨证治疗 CU 的研究多停留于临床疗效的观察和经验总结，缺乏真实世界的的数据。

真实世界研究(Real world study, RWS)是指在真实临床、社区或家庭环境下，获取多种数据，从而评价某种治疗措施对患者健康真实影响的研究，其以患者为中心，与中医的整体观念相契合^[5-6]。而我国中医领域的 RWS 多注重对中药与中药制剂的研究，对传统药方等方面的研究还有较大空缺。因此，本课题基于真实临床诊疗环境下，对六经辨证治疗 CU 的临床疗效及安全性进行观察，期望可以得出一套具有推广性、行之有效的六经辨证治疗 CU 的具体临床方案，提高慢性荨麻疹辨证的准确率，提高其临床疗效、安全性。同时将真实世界的经验转化为真实世界的证据，为传统药方治疗 CU 的临床疗效提供更有力的证据。

1 材料

1.1 病例来源

本研究病例均源自 2021 年 9 月-2022 年 9 月重庆市中医院（道门口院部）皮肤科门诊就诊患者，所有患者均符合 CU 的中西医诊断标准，最终本研究共纳入符合纳排标准的 CU 患者 126 例。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照中国荨麻疹诊疗指南(2018 版)^[7]及赵辨主编的《中国临床皮肤病学》^[8]相关内容制定西医诊断标准:

- (1) 临床表现为风团和/或血管性水肿，发作形式多样，风团的大小和形态不一，发作时间不定，多伴有瘙痒。
- (2) 风团通常在 24 小时内消退，少数可长至数天后消退，消退后不留痕迹。
- (3) 风团每天发作或间歇发作，反复发作达每周至少两次，且持续时间>6 周。

1.2.2 中医诊断标准

参考陈红风主编的新世纪第 5 版《中医外科学》^[9]相关内容制定中医诊断标准:

- (1) 皮肤出现风团，色红或白，形态各异。
- (2) 发无定处，骤起骤退，退后不留痕迹，自觉瘙痒。
- (3) 风团时多时少，反复发生，病程在 6 周以上。

1.3 数据排纳

1.3.1 纳入标准

- (1)符合慢性荨麻疹的中医诊断标准、西医诊断标准;
- (2)年龄、男女不限;
- (3)患者自愿参加本研究并签署知情同意书。

1.3.2 排除/剔除标准

- (1)不符合慢性荨麻疹的中医诊断标准、西医诊断标准;
- (2)病历资料不完整;
- (3)合并有严重心、脑血管、肝肾、免疫系统等疾病的患者;
- (4)服药依从性差,不愿配合或无法合作者,如有认知障碍、精神疾病的患者。

1.3.3 病例脱落标准

未能完成治疗者,失访及自动退出者;

1.3.4 病例中止标准

出现严重不良反应或病情加重,不宜继续进行治疗者。

2 方法

2.1 病例资料的收集与处理

2.1.1 病例资料的收集

初次在荨麻疹专病门诊就诊的患者要求完成患者的一般资料(包括姓名、性别、年龄、职业、电话、慢性荨麻疹发病时间、伴发疾病及用药、家族过敏史、治疗前的用药)、慢性荨麻疹患者活动程度评分(UAS-7)、中医四诊表(包括六经辨证依据等)、治疗方案(具体药物及剂量)。复诊患者要求记录患者的一般资料(包括姓名、年龄、性别)、慢性荨麻疹患者活动程度评分(UAS-7)、中医四诊表、治疗方案、不良反应。

2.1.2 病例资料的处理

将纳入本研究患者的基本信息,用 Excel 软件录入表格保存,并及时将汇总数据录入 HIS 系统的科研系统中。

2.2 随机分组

将符合纳排标准的 150 例慢性荨麻疹患者按随机数字表法^[10],分为治疗组 75 例,对照组 75 例。

2.3 治疗方案

2.3.1 对照组

依据中国荨麻疹诊疗指南(2018 版)^[7]建议, 推荐使用第二代抗组胺药物作为慢性荨麻疹患者的常规治疗, 故本研究对照组予以口服第二代抗组胺药物治疗。

2.3.2 治疗组

治疗组根据六经辨证予以相应中药处方治疗。

根据《伤寒论》、《解读张仲景医学经方六经类方证》^[11]相关内容及导师临床经验拟定六经辨证分型标准 (具体见附录一) :

太阳病类证: 恶寒, 发热, 头项强痛等。

临床常见症状: 易感冒, 恶风, 头痛 (颈项部), 关节疼痛, 脉浮紧或浮缓。

阳明病类证: 口干, 口渴, 胃家实, 身热, 自汗出, 不恶寒反恶热等。

临床常见症状: 恶热, 头痛 (前额、眉棱骨), 口臭, 渴喜冷饮, 多食易饥, 大便干, 白带黄臭, 脉洪大或沉实而迟。

少阳病类证: 口苦, 咽干, 目眩, 胸胁苦满, 寒热往来, 默默不欲饮食等。

临床常见症状: 多言善动, 易怒, 四肢冷, 头颈汗出, 手足汗出, 头痛 (两侧), 目痒, 咽痒, 咽喉异物感, 口苦, 乳房胀痛, 恶心、反胃, 睡眠易惊醒, 脉弦细。

太阴病类证: 腹满而吐, 食不下, 自利不渴, 腹痛等。

临床常见症状: 头晕, 易困乏, 咽喉有痰, 口吐清涎, 不渴, 口淡无味, 不饿少食, 食后作胀, 睡眠多梦, 大便稀溏, 饮则多尿, 白带清晰量多, 脉沉。

少阴病类证: 无热恶寒, 困倦少神, 精神不振等。

临床常见症状: 神情淡漠, 易疲惫, 畏寒, 腰酸, 入睡困难, 夜尿频多, 脉浮微细。

厥阴病类证: 气上撞心, 心中疼热, 饥而不欲食, 上热下寒, 寒多, 微有热, 或但寒不热。

临床常见症状: 口腔溃疡, 心下痞满。

2.3.3 治疗疗程

疗程为 8 周, 两周为 1 个疗程, 两周复诊 1 次, 复诊时评估患者病情并记录观察指标, 治疗结束 1 个月后进行电话随访。

2.3.4 注意事项

服药期间应尽量清淡饮食，忌食辛辣，尽量避免食用牛肉、羊肉、鱼虾、海鲜等容易诱发及加重荨麻疹病情的食物。

2.4 观察指标

2.4.1 一般资料

患者性别、年龄、病程等资料。

2.4.2 疗效评价指标

荨麻疹活动程度评分量表 (UAS-7)^[7] (具体见附录二)

UAS-7 根据慢性荨麻疹患者发作的风团和瘙痒进行评分，分别划分为 4 个等级，记分为 0~3 分。其中没有风团为 0 分，风团（小于 20 个/24 小时）为 1 分，风团（在 20-50 个/24 小时）为 2 分，风团（在大于 50 个/24 小时或大面积）为 3 分。没有瘙痒为 0 分，有瘙痒但不明显为 1 分，明显瘙痒但不影响日常生活或睡眠为 2 分，严重瘙痒、不能忍受或严重困扰日常生活或睡眠为 3 分。每日评分记风团与瘙痒总分，范围为 0~6 分，1 周连续最高评分为 42 分；若周评分小于 7 分，提示疾病控制；若周评分大于 28 分，则提示病情严重。分别于治疗前，第 1 周，第 2 周，第 3 周，第 4 周，第 5 周，第 6 周，第 7 周，第 8 周采用 UAS-7 进行评估。

2.4.3 安全性指标

观察患者在用药期间的不良反应，包括恶心、呕吐、腹泻、腹痛等，并且记录在案。

2.5 疗效评定标准

2.5.1 总有效率

根据《中药新药临床研究指导原则》^[12]制定疗效评价标准：

(1)治愈：治疗后各症状消失，减轻程度 $\geq 90\%$ ；

(2)显效：治疗后各症状明显减轻，减轻程度在 60%-90% ；

(3)有效: 治疗后各症状有所减轻, 减轻程度在 30%-60%;

(4)无效: 治疗后各症状无减轻或者有加重, 减轻程度<30%。

总有效率= [(临床治愈例数+显效例数+有效例数) /总例数] × 100 %

2.5.2 复发率

治疗结束 1 个月后, 通过电话随访显效和治愈的慢性荨麻疹患者, 统计荨麻疹复发的例数。

复发率=复发例数/总有效例数 × 100%

2.6 统计学方法

所有资料采用 SPSS26.0 统计软件进行统计学分析, 计数资料采用卡方检验, 等级资料采用秩和检验进行统计分析; 计量资料, 服从或近似服从正态分布的数据, 用平均数和标准差的形式表示, 采用 t 检验, 不服从正态分布的数据, 采用 Mann-Whitney 检验, 当 $P < 0.05$ 时, 认为差异具有统计学意义, $P < 0.01$ 为有显著统计学意义。

3 结果

3.1 纳入病例情况

本研究 2 例治疗组患者因外地求学中止服药, 3 例对照组患者因外地务工而脱落, 11 例治疗组患者及 8 例对照组患者因新型冠状病毒流行期间无法按时复诊用药, 未能完整参与本试验而剔除。最终, 本研究实际纳入治疗组 62 例, 对照组 64 例, 共计 126 例患者。

3.2 基线资料比较

3.2.1 慢性荨麻疹患者的性别比较

本研究最终共纳入 126 例慢性荨麻疹患者, 其中女性 87 人, 男性 39 人, 分别占比 69.0%, 31.0%, 男女比率为 1:2.2。其中治疗组男性 20 例 (32.3%), 女

性 42 例 (67.7%)；对照组男性 19 例 (29.7%)，女性 45 例 (70.3%)。两组患者性别资料经 χ^2 检验， $\chi^2 = 0.097$ ， $P = 0.755$ ($P > 0.05$)，结果显示两组患者性别构成无统计学差异，具有可比性 (见表 1)。

表 1 两组患者性别资料比较

Table 1 Comparison of gender data between the two groups

组别	例数	男[例(%)]	女[例(%)]	χ^2	P
治疗组	62	20 (32.3%)	42 (67.7%)	0.097	0.755
对照组	64	19 (29.7%)	45 (70.3%)		

3.2.2 慢性荨麻疹患者的年龄比较

受试者中未成年人 8 人 (<18 岁)，占 6.35%，青年人 76 人 (18~44 岁)，占 60.32%，中年人 34 人 (45~59 岁)，占 26.98%，老年人 8 人 (>60 岁)，占 6.35%，其中最年轻为 12 岁，最大年龄 71 岁，平均年龄 38.4 岁。两组患者年龄资料均符合正态分布且方差齐，经独立样本 t 检验进行差异性分析，治疗组患者平均年龄 40.06 ± 13.69 ，对照组患者平均年龄 36.38 ± 14.13 ， $t = 1.488$ ， $P = 0.139$ ($P > 0.05$)，结果显示两组患者年龄无统计学差异，具有可比性 (见表 2)。

表 2 两组患者年龄资料比较

Table 2 Comparison of age data between the two groups

组别	例数	年龄(岁)	t	P
治疗组	62	40.06 ± 13.69	1.488	0.139
对照组	64	36.38 ± 14.13		

3.2.3 慢性荨麻疹患者的病程比较

病程<1 年的患者有 72 例，占 57.14%，1-5 年 37 例，占 29.37%，5-10 年 13 例，占 10.32%，>10 年 4 例，占 3.17%。两组患者病程经正态性检验后不符合正态分布，故采用 Mann-Whitney 检验进行差异性分析， $Z = -3.4$ ， $P = 0.001$ ($P < 0.05$)，结果显示两组患者病程有统计学差异 (见表 3)。

表 3 两组患者病程资料比较

Table 3 Comparison of disease course data between the two groups

组别	例数	病程(月)	<i>Z</i>	<i>P</i>
治疗组	62	12.5(5,48.75)	-3.4	0.001
对照组	64	6(3,12)		

3.3 慢性荨麻疹患者 UAS-7 积分比较

3.3.1 两组治疗前后 UAS-7 积分组内比较

治疗组治疗前 UAS-7 积分 20.98 ± 9.14 , 治疗后 UAS-7 积分 8.94 ± 7.68 , 对照组治疗前 UAS-7 积分 18.98 ± 7.18 , 治疗后 UAS-7 积分 11.17 ± 8.77 。治疗组和对照组患者 UAS-7 积分治疗前后的差值符合正态分布, 故采用配对样本 *t* 检验进行差异性分析, 治疗组患者治疗前后的 UAS-7 积分组内比较, $t = 12.048$, $P = 0.001$ ($P < 0.01$), 结果显示治疗组患者治疗前后的 UAS-7 积分比较差异具有显著统计学意义; 对照组患者治疗前后的 UAS-7 积分组内比较, $t = 7.263$, $P = 0.001$ ($P < 0.01$), 结果显示对照组患者治疗前后的 UAS-7 积分比较差异具有显著统计学意义 (见表 4)。

表 4 治疗前后 UAS-7 积分组内比较

Table 4 Intra-group comparison of UAS-7 scores before and after treatment

组别	例数	治疗前	治疗后	<i>t</i>	<i>P</i>
治疗组	62	20.98 ± 9.14	8.94 ± 7.68	12.048	0.001
对照组	64	18.98 ± 7.18	11.17 ± 8.77	7.263	0.001

3.3.2 两组治疗前后 UAS-7 积分的组间比较

治疗组治疗前 UAS-7 积分 20.98 ± 9.14 , 治疗后 UAS-7 积分 8.94 ± 7.68 , 对照组治疗前 UAS-7 积分 18.98 ± 7.18 , 治疗后 UAS-7 积分 11.17 ± 8.77 。两组患者治疗前 UAS-7 积分经正态性检验后符合正态分布, 采用独立样本 *t* 检验进行差异性分析, $t = 1.368$, $P = 0.174$ ($P > 0.05$), 结果显示两组患者治疗前 UAS-7 积分组间比较, 差异无统计学意义; 两组患者治疗后 UAS-7 积分不符合正态分

布, 故采用 Mann-Whitney 检验进行差异性分析, $Z=-1.569$, $P=0.117$ ($P>0.05$), 结果显示两组患者治疗后 UAS-7 积分组间比较, 差异无统计学意义; 两组患者 UAS-7 积分差值经正态性检验后符合正态分布, 故采用独立样本 t 检验进行差异性分析, $t=2.935$, $P=0.004$ ($P<0.01$), 结果显示两组患者 UAS-7 积分差值比较, 差异具有显著统计学意义 (见表 5)。

表 5 治疗前后 UAS-7 积分组间比较

Table 5 Comparison of UAS-7 scores between the two groups before and after treatment

组别	例数	治疗前	差值 (治疗前-治疗后)
治疗组	62	20.98±9.141	12.05±7.54
对照组	64	18.98±7.18	7.81±8.61
t		1.368	2.935
P		0.174	0.004

3.4 总体疗效比较

疗效评价为等级资料, 采用秩和检验进行统计分析, $Z=-2.083$, $P=0.037$ ($P<0.05$), 治疗组总有效率 87.10%, 对照组总有效率 71.88%, 治疗组经治疗后疗效优于对照组, 结果显示两组患者疗效差异有统计学意义 (见表 6)。

表 6 两组患者临床疗效比较

Table 6 Comparison of clinical efficacy between the two groups

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	有效率	Z	P
治疗组	62	6	28	20	8	87.10%	-2.083	0.037
对照组	64	6	18	22	18	71.88%		

3.5 疗效相关性分析 (疗效与性别、年龄、病程、UAS-7 积分)

采用多元 Logistic 回归分析比较性别、年龄、病程、治疗前后的 UAS-7 积分对疗效的影响。结果显示性别、年龄及病程对疗效的影响均无统计学意义 ($P>0.05$); 治疗前后的 UAS-7 积分均对疗效的影响有显著统计学意义 ($P<0.001$),

其中治疗前 UAS-7 积分对其为负向影响 ($\beta < 0$)，即治疗前的得分越高，则疗效越好，治疗后 UAS-7 积分对其为正向影响 ($\beta > 0$)，治疗后 UAS-7 积分的得分越高，则疗效越差 (见表 7)。

表 7 两组患者疗效的 Logistic 回归分析结果

Table 7 Logistic regression analysis of efficacy in two groups

	未标准化系数		标准化系数		显著性	VIF	调整后 R^2	F
	B	标准错误	Beta	t				
(常量)	2.269	.135		16.764	0.001*			
性别	-.030	.079	-.015	-.383	.703	1.031		
年龄	.002	.003	.037	.917	.361	1.076	0.809	106.752*
病程	5.007E-5	.001	.004	.090	.928	1.120		
治疗前积分	-.044	.005	-.393	-8.460	0.001*	1.411		
治疗后积分	.114	.005	1.029	22.493	0.001*	1.369		
因变量: 疗效								

* $P < 0.001$

3.6 复发率统计

治疗结束 1 个月后电话随访，治疗组复发 13 例，复发率为 24.07%；对照组复发 17 例，复发率为 36.96%，经 χ^2 检验， $\chi^2 = 1.963$ ， $P = 0.161$ ($P > 0.05$)，结果显示两组复发率无统计学差异 (见表 8)。

表 8 两组患者复发率比较

Table 8 Comparison of recurrence rate between the two groups

组别	总有效例数	复发例数	未复发例数	χ^2	P
治疗组	54	13	41	1.963	0.161
对照组	46	17	29		

3.7 六经辨证分型

依据六经辨证施治，在 62 例患者中，少阳太阴合病证 29 例，占 46.8%，太阳太阴合病证 8 例，占 12.9%，少阳阳明合病证 7 例，占 11.3%，太阴少阴合病

证 6 例, 占 9.7%, 太阳阳明合病证 4 例, 占 6.5%, 阳明证类 3 例, 占 4.8%, 厥阴证类 3 例, 占 4.8%, 太阳证类 1 例, 占 1.6%, 少阳证类 1 例, 占 1.6%。

3.8 安全性评价

治疗组中 1 例患者在用药过程中出现腹泻情况, 调整中药处方后腹泻症状消失, 余患者未见明显异常, 两组受试者用药安全性均良好。

4 讨论

4.1 真实世界研究在中医药领域中的应用

真实世界研究(real world study, RWS)是指在真实临床、社区或家庭环境下, 获取多种数据, 从而评价某种治疗措施对患者健康真实影响的研究^[13]。1993 年 Kaplan^[14]等首次以发表论文的形式明确提出了 RWS 的概念, 相比于随机对照研究(randomized control trial, RCT), RWS 纳入的人群均为临床实际的患者群体, 对患者的病情限定较宽泛, 覆盖人群广, 样本量通常较大, 结果基于临床真实环境, 外部真实性好^[15]。中医强调辨证论治, 从整体出发, 强调根据患者的具体情况, 结合所处的环境、气候, 给予不同的干预措施或处方, 但目前公认的评价手段 RCT 要求简单明确的干预措施、成功的对照措施、高度同质的研究人群等, 不能充分体现中医药整体观念和辨证论治的特点。而 RWS 则以患者为中心, 评价指标上重视具有重要临床意义的终点指标及与患者生活状态密切相关的指标, 与中医的整体观念相契合^[16]。陈吉^[17]等通过检索数据库, 搜集已发表的中医领域的真实世界研究文献, 认为中医领域真实世界研究多运用数据挖掘方法对中药制剂用药进行研究。研究者对中药的关注热度高于中医诊疗手段, 对中药制剂高于传统中药, 而对传统中药、药方及传统诊治手段的关注有待提高。通过上述内容我们可以得知真实世界研究相比传统的随机对照试验而言, 更契合中医临床的诊疗模式, 而我国中医领域的真实世界研究多注重对中药与中药制剂的研究, 对传统药方等方面的研究还有较大空缺。而经方作为我国传统文化的瑰宝, 其疗效已反复被临床实践所验证, 对于慢性荨麻疹甚至难治性荨麻疹也有较好的疗效, 但目前大多学者对经方的研究多停留于临床疗效的观察和经验总结, 缺乏真实世界的数据。

4.2 祖国医学对慢性荨麻疹的研究

4.2.1 病因病机

祖国医学对荨麻疹有较早的认识,如《金匱要略·水气病邪脉证并治》言“风气相搏,风强则为瘾疹,身体为痒,痒为泄风。”《诸病源候论·风骚身体瘾疹候》曰:“邪气客于皮肤,复逢风寒相折,则起风瘙瘾疹。若赤疹者,由凉湿折于肌中之热,热结成赤疹也……脉浮而洪,浮即为风,洪则为气强。风气相搏,瘾疹,身体为痒。”古代医家对本病多有论述,认为风、寒、湿邪等外感六淫均可导致本病的发生,而风善行而数变,为百病之长,强调风邪是荨麻疹发病的核心病机。

除风邪外,古人认为卫表不固,脏腑失调也是荨麻疹发病的重要原因。《医宗金鉴》曰:“由汗出受风,或露卧乘凉,风邪多中表虚之人。”提出表虚不固是荨麻疹发病的重要因素。《三因极一病证方论》云:“世医论瘾疹,无不谓是皮肤间风,然既分冷热,冷热即寒暑之证……心实热则痛,虚寒则痒。又阳明主肌肉,属胃与大肠,亦有冷热分痛痒……内则查其脏腑虚实,外则分其寒暑风湿,随证调之,无不愈。”《医宗金鉴·疹门》:“瘾疹者,乃心火灼于肺金,又兼外受风湿而成。发必多痒,色则红赤,隐隐于皮肤之中,故名曰瘾疹。”认为本病病因不仅与风邪有关,脏腑的虚实也可以导致发病。现代中医,如张苍^[18]等多位专家不仅强调风邪是慢性荨麻疹的核心病机,认为风有内外、经络、脏腑之别,而且认为风邪入络、寒热并存、虚实兼夹、阴阳并见是荨麻疹顽固化的重要原因。综上所述,风邪是荨麻疹发病的核心病机,表虚不固、脏腑气血阴阳的失调,多种病理因素兼夹存在,是导致荨麻疹缠绵难愈的重要因素。

4.2.2 中医治疗方法

本病目前在中医辨证分型上尚不统一。中医本科教材《中医外科学》根据致病因素的不同,将荨麻疹分为风寒束表、风热犯表、胃肠湿热、气血两虚、冲任失调 5 个证型。分别治以疏风散寒止痒,疏风清热止痒,疏风解表、通腑泄热,益气补血、熄风潜阳,调摄冲任。常予桂枝麻黄各半汤、消风散、防风通圣散合茵陈蒿汤、八珍汤、四物汤合二仙汤等方加减。2017 年荨麻疹中医治疗专家共识^[19]将毒热炽盛证列入常用 5 种证型。认为实证者应以疏风清热、疏风散寒或清

热利湿、凉血解毒祛邪为主；虚证者以益气养血，固表扶正为主；虚实夹杂者扶正与祛邪并用。张作舟^[20]老中医将荨麻疹分为表虚不固、血虚气弱、阴虚内热和湿热内蕴 4 种类型，治以固卫和营、佐以酸敛，养血熄风、内外同治，滋阴清热、潜阳熄风，清热理脾、宣化湿浊等，临床取得较好疗效。杨洁^[21]等通过整理有关慢性荨麻疹从心、肝、脾、肺、肾及多脏腑论治的相关研究，认为当前多数医家已认识到脏腑辨证在慢性荨麻疹诊治过程中的重要性，从脏腑论治可达到调整阴阳、除病祛邪的目的。熊兴江^[22]等认为经方是在方证对应原则指导下，从整体出发，针对患者症状及体征用药。作者运用柴胡桂枝汤、桂枝汤、麻黄连翘赤小豆汤等治疗慢性荨麻疹，均取得一定疗效。从上述内容我们可以得出，临床上慢性荨麻疹患者的症状多样、病机复杂，往往多种证候相互兼夹，传统单一的证型难以一一对应。中医关于慢性荨麻疹的辨证方式多样，常运用病因辨证、气血辨证、脏腑辨证、六经辨证等辨证方法。

4.2.3 六经辨证辨治慢性荨麻疹概况

经方的概念有广义与狭义之分，广义之经方指古代医家通过长期实践，所获得的确有疗效的经验之方，狭义之经方特指仲景之方^[23]。皇甫谧曰“仲景论广《伊尹汤液》为十数卷，用之多验。”，仲景选用经方，紧密结合临床，将方证标准化，形成了独特的六经辨证理论体系。对于六经辨证的实质，各医家所持观点不一。胡希恕先生谓“其实六经即来自八纲，乃万病的总纲。”，张仲景在八纲中加入了半表半里的理念，从而形成了六经辨证论治体系^[24]。刘渡舟先生则认为六经是由脏腑经络所组成，六经的证候活动规律仍在八纲的范畴^[25]。欧阳卫权^[26]梳理诸家，认为六经以八纲为核心，同时涵盖脏腑、经络。若欲以六经辨证辨治疾病，应先辨六经，次辨方证，依据方证相应的原则，随证治之。六经即三阴三阳经，三阳经指太阳、阳明、少阳，三阴经指太阴、少阴、厥阴，辨治疾病应首先辨明六经分清主要方向，再抓取主证，选取对应方剂，若有合病、并病，应合方予之。经查阅经方治疗荨麻疹的相关文献，发现虽因“太阳主表”，太阳病类方在皮肤疾病方面的应用较多，但其他各经也多有涉及，现代中医学者常应用经方治疗荨麻疹，临床疗效显著。

1、太阳病类方

“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒”。太阳病方多运用麻黄汤类方、桂枝汤类方、麻桂合剂、麻杏石甘汤等，应用于表证。

李朝辉^[27]等人用加减麻黄汤治疗急性荨麻疹 126 例，治疗 2~3 个疗程，结果显示治愈 76 例，好转 39 例，无效 11 例，总有效率 91.27%。王红军^[28]采用自拟加味麻黄汤治疗 30 例寒冷性荨麻疹患者，疗程为 2 周，疗效显著。

周昶^[29]选取慢性特发性荨麻疹患者 96 例，按随机数字表法分为观察组和对照组。对照组服用枸地氯雷他定片，观察组在对照组基础上联合桂枝汤加减治疗，连续治疗 28 天，结果观察组总有效率高于对照组。

韩洁茹^[30]等将 120 例寒冷性荨麻疹患者随机分为两组各 60 例，对照组用常规西药西替利嗪、维生素 C 治疗，治疗组在用桂枝麻黄各半汤加味联合西替利嗪治疗，治疗后治疗组瘙痒程度、风团数量、风团持续时间、腹痛程度症状积分显著低于对照组。

江丽莹^[31]等将 160 例慢性荨麻疹患者随机分为两组，对照组 80 例口服盐酸西替利嗪分散片、盐酸依匹斯汀胶囊治疗，治疗组 80 例在对照组治疗的基础上加服麻杏石甘汤加减治疗。结果对照组治疗后总有效率为 73.75%，治疗组治疗后总有效率为 86.25%，得出麻杏石甘汤加减联合西药治疗慢性荨麻疹有明显的疗效，且复发率低。

2、阳明病类方

“阳明之为病，胃家实是也”，阳明病方多运用白虎汤、三承气汤类等，用于里实热证。

刘金荣^[32]运用调胃承气汤合白虎汤治疗荨麻疹 72 例，治疗后 1 个月内未再复作者 48 例，有 1 次发作者 2 例，有 2 次以上发作者 2 例，总有效率 97.3%。赵文斌^[33]等用小承气汤治疗阳明腑实证慢性荨麻疹患者。患者女，34 岁，全身红斑风团伴瘙痒反复发作 2 年余，2 年内皮疹反复发作，洗澡后及遇冷加重，严重时遇风即起，每天约发作 6~8 次。患者既往长期便秘病史。现症见：全身散在淡红斑，皮肤划痕症（+），伴大便秘结，4 日未行，腹胀，渴喜冷饮，小便黄少，舌质红苔黄，脉滑数。中医诊断瘾疹，辨证属于肠道积滞伴风热外袭证。治以荡涤肠腑、搜风固表，方用小承气汤加减：大黄 15 g，厚朴 15 g，枳实 10 g，防风 15 g，荆芥 12 g，黄芩 15 g，苍耳子 9 g，生白术 30 g，乌梢蛇 12 g，地龙

12 g。二诊，上方服 7 剂后患者诉瘾疹发作次数稍有减少，约 5~6 次每天，大便仍不甚通畅，遂将上处方厚朴改为 20 g，枳实改为 30 g，瓜蒌 30 g。三诊，上方服 7 剂后患者诉瘾疹发作次数明显减少，仅偶发 1 次，大便通畅，日一次，改成药消风止痒颗粒继服 7 日。

3、少阳病类方

“少阳之为病，口苦、咽干、目眩也”，少阳病方多运用柴胡类方等，应用于半表半里证。

李腾龙^[34]等将 94 例急性荨麻疹伴发热患者随机分为观察组与对照组各 47 例。对照组采用氯雷他定和维生素 C 治疗，观察组在对照组治疗基础上加用小柴胡汤加减结合刺络拔罐治疗，比较两组的临床疗效、症状及血清中免疫球蛋白 E、5-羟色胺和干扰素的水平，结果 观察组治疗总有效率高于对照组。陈谦峰^[35]等运用大柴胡汤治疗荨麻疹，宁某，女，42 岁，荨麻疹反复发作已 5 年，多发于外感之后。此次发作已半月余，皮疹从两下肢向上蔓延，瘙痒难忍，胃胀纳少，大便秘结，苔薄黄，脉沉稍数。此因肠胃实热所致，治拟通腑泻热、祛风止痒。大柴胡汤去生姜、大枣，改白芍为赤芍，加荆芥、防风、苦参、白蒺藜、浮萍。3 剂后，皮疹减少，瘙痒减轻，胃胀减轻，大便通畅。守上方续进 5 剂而瘥。

4、太阴病类方

“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬”，太阴病方多运用理中汤、建中汤类方等，应用于里虚寒证。

尹云斌^[36]将 60 例患者随机分为黄芪建中汤加味治疗组和祛风止痒口服液对照组各 30 例。总疗程为 4 周，治疗结束后治疗组痊愈率 60%，有效率 93.33%；对照组治愈率为 26.67%，总有效率为 66.67%。刘亭亭^[37]等将 68 例寒冷性荨麻疹患者随机分成 2 组进行对比观察。治疗组予桂附理中汤加味，对照组予氯雷他定片，10 天为 1 个疗程，连用 2 个疗程后评价疗效。结果：治疗组有效率 97%，对照组有效率 76.5%。

5、少阴病类方

“少阴之为病，脉微细，但欲寐也。”，少阴病方多运用麻黄附子细辛汤、真武汤等，用于心肾阳虚患者，运用黄连阿胶汤治疗阴虚火旺证。

徐俊涛^[38]等选取 88 例慢性自发性荨麻疹患者为研究对象。采用随机数字表法将其分为观察组与对照组，各 44 例。对照组给予依巴斯汀片口服，观察组在对照组的基础上给予麻黄附子细辛汤，以 4 周为 1 个疗程，治疗后，观察组瘙痒、风团数目、风团直径、风团出现频率、风团持续时间积分低于对照组，观察组总有效率高于对照组。肖月园^[39]等通过对 568 例慢性荨麻疹患者的电话回访，分析其中临床治愈的 198 例慢性荨麻疹患者的中医辨证分型，统计病例中临床常用方剂的应用次数，总结临床治疗慢性荨麻疹的有效方剂，其中真武汤运用 23 次。陈芒华^[40]等运用黄连阿胶汤治疗荨麻疹患者 1 例，患者乙，男，38 岁，反复起风团 1 年余。1 年来皮疹瘙痒反复发作，先后在多家三甲医院就诊，诊为荨麻疹。现症见：身痒，皮疹，汗出多，恶热，心烦不眠，晨起口苦，思凉饮，二便调，皮肤划痕征（+）。舌红，苔白，抚心肾二脉微细。诊为荨麻疹，予黄连阿胶汤，处方：黄连四两（60 g），黄芩一两（15 g），芍药二两（30 g），鸡子黄二枚，阿胶三两（45 g），以水六升，先煮三味，取二升，去滓，纳胶烊尽，小冷，纳鸡子黄，搅令相得，温取七合，日三服，嘱次日复诊。二诊，患者于数日后前来复诊，诉服药三碗，当晚睡眠深，微出汗，未因瘙痒而起，翌日见风团稍小，不痒，随后因未注意而食辛辣，遂再发而前来复诊，同方予之，嘱连服两日后复诊。三诊，已愈，后未再发。

6、厥阴病类方

“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止”，厥阴病方多运用乌梅丸等，用于寒热错杂证。

张军斌^[41]选择 80 例慢性荨麻疹患者，随机分为治疗组（口服乌梅丸方加自血治疗）和对照组（口服诺思达加自血治疗）两组，每组 40 例，连续治疗 4 周，经治疗侯结果显示服用乌梅丸方的患者症状改善情况及复发加重率优于服用诺思达的患者。

4.3 验案举隅

患者甲，青年女性，2022 年 06 月 20 日就诊，全身反复红斑风团伴瘙痒 4 年，既往服用富马酸卢帕他定片、阿伐斯汀胶囊等抗组胺药物治疗后病情可缓解，但风团伴瘙痒仍频繁发作，经久难愈。现症见全身红斑风团伴瘙痒，风团色鲜红，大小、形态不一，发作以双足部为重，瘙痒剧烈。自诉手足心热，少汗，头痛，

疼痛以前额、眉棱骨、两侧为主，眼睛干痒，口苦，乳房胀痛，晨起手指关节肿胀感，腰痛，双膝酸软，二便正常，平素不欲饮水，情绪压抑，易困乏。月经量少，色黯，白带量少。舌脉：舌淡红，舌尖有点刺，苔薄白，舌下络脉迂曲，双脉弦细滑，略涩，双尺沉弱。西医诊断：慢性荨麻疹。中医诊断：瘾疹。辨证为少阳病，治以和解少阳，方以柴桂温胆定志汤加减，具体方药如下：北柴胡 10g 黄芩片 10g 桂枝 10g 赤芍 10g 白芍 10g 法半夏 10g 陈皮 10g 麸炒枳壳 10g 竹茹 10g 茯苓 12g 南沙参 10g 石菖蒲 10g 大枣 6g 炙甘草 6g 制远志 10g。10 剂，每日 1 剂，水煎服。二诊：2022 年 7 月 01 日，患者诉服药期间未再服用西药治疗，红斑风团发作次数及程度较前减少。手足心热、乳房胀痛、晨起指关节肿胀感消失，腰膝酸软、情绪压抑缓解，少汗、头痛、眼睛干痒、口苦、不欲饮水、困乏同前。近 1 周因感冒后出现流鼻涕、打喷嚏、鼻塞、流泪、咽喉干痛。舌脉：舌淡红，舌尖红，苔薄白，右脉缓滑，左脉略弦郁，左尺浮。以前方加用炒苍耳子 5g，辛夷 5g，白术 8g，麸炒白术 8g，10 剂，每日 1 剂，水煎服。三诊：2022 年 07 月 15 日，患者诉风团发作明显好转，停药一周未发作，现情绪压抑明显缓解，流鼻涕、打喷嚏、鼻塞、流泪、咽喉干痛、眼睛干痒、头痛、腰膝酸软症状消失，困乏减轻，少汗、口苦、不欲饮水同前。舌脉：舌淡，舌尖红，双脉弦郁，尺脉弱。以前方减炒苍耳子，辛夷，加用盐菟丝子 10g，盐杜仲 10g，续服 10 剂巩固疗效。柴桂温胆定志汤组方如下：柴胡 10g，黄芩 10g，桂枝 10g，赤芍 10g，白芍 10g，半夏 10g，生姜 10g，陈皮 10g，枳壳 10g，竹茹 10g，茯苓 20g，人参 5g，菖蒲 6g，远志 10g，大枣 5 枚，炙甘草 6g。柴桂温胆定志汤为郝万山教授所创制，临床用于治疗抑郁症多有验效。郝万山教授认为精神抑郁症的病机为心胆阳虚，脑神失养，肝虚气郁，痰蒙神窍，以柴桂温胆定志汤温补心胆、疏肝解郁、豁痰开窍、养脑醒神，方以小柴胡汤、桂枝汤、温胆汤、定志丸、四逆散等合方化裁。^[42]方中小柴胡汤（柴胡、黄芩、半夏、人参、生姜、大枣、甘草）和解少阳，桂枝汤（桂枝、芍药、生姜、大枣）解肌发表，调和营卫，小柴胡汤、桂枝汤均出自《伤寒论》，温胆汤（竹茹、枳壳、半夏、陈皮、生姜、甘草）理气化痰，清胆和胃，定志丸（人参、茯苓、菖蒲、远志）益气安神，宁心定志，四逆散（柴胡、枳壳、芍药、甘草）调和肝脾。柴桂温胆定志汤为治疗精神抑郁症所创制，少阳之为病，口苦，咽干，目眩也，患者精神抑郁、眼睛干痒、口苦、

乳房胀痛、脉弦等均为少阳证的典型症状，六经辨证应属少阳证，予以柴桂温胆定志汤和解少阳，则用之验效。

4.4 临床研究结果及分析

4.4.1 基线数据分析

本研究收集 126 例慢性荨麻疹患者，其中女性 87 人，男性 39 人，分别占比 69.0%，31.0%，男女比率为 1:2.2，可见慢性荨麻疹患者中女性患者占比较男性患者更大，结果与 2018 版中国荨麻疹指南^[7]数据相符。

受试者中未成年人 8 人 (<18 岁)，占 6.35%，青年人 76 人 (18~44 岁)，占 60.32%，中年人 34 人 (45~59 岁)，占 26.98%，老年人 8 人 (>60 岁)，占 6.35%，其中最年轻为 12 岁，最大年龄 71 岁，平均年龄 38.4 岁，表明中青年人群为慢性荨麻疹好发人群，结果大致与 2018 版中国荨麻疹指南^[7]数据相符。

病程<1 年的患者有 72 例，占 57.14%，1-5 年 37 例，占 29.37%，5-10 年 13 例，占 10.32%，>10 年 4 例，占 3.17%，其中病程在 1 年以内的患者人数超过总数的 1/2，占比最大，病程超过 10 年的患者人数最少。

4.4.2 两组治疗前后 UAS-7 积分分析

治疗组治疗前 UAS-7 积分 20.98 ± 9.14 ，治疗后 UAS-7 积分 8.94 ± 7.68 ，对照组治疗前 UAS-7 积分 18.98 ± 7.18 ，治疗后 UAS-7 积分 11.17 ± 8.77 。治疗组和对照组患者治疗前后的 UAS-7 积分比较差异均具有显著统计学意义 ($P < 0.001$)，提示经治疗后病情均较前有明显改善。两组患者治疗前 UAS-7 积分组间比较，差异无统计学意义 ($P > 0.05$)，具有可比性。两组患者治疗后 UAS-7 积分组间比较，差异无统计学意义 ($P > 0.05$)，两组患者 UAS-7 积分差值比较，差异具有显著统计学意义，($P < 0.01$)，提示治疗组患者 UAS-7 积分较对照组改善更大。

4.4.3 疗效相关性分析

采用多元 Logistic 回归分析比较性别、年龄、病程、治疗前后的 UAS-7 积分对疗效的影响。结果显示性别、年龄及病程对疗效的影响均无统计学意义 ($P > 0.05$)；治疗前后的 UAS-7 积分均对疗效的影响有显著统计学意义 ($P < 0.001$)，

其中治疗前 UAS-7 积分对其为负向影响 ($\beta < 0$)，即治疗前的 UAS-7 积分得分越高，则疗效越好，治疗后 UAS-7 积分对其为正向影响 ($\beta > 0$)，治疗后 UAS-7 积分的得分越高，则疗效越差。

4.4.4 六经辨证分型分析

依据六经辨证施治，在 62 例患者中，少阳太阴合病证 29 例，占 46.8%，太阳太阴合病证 8 例，占 12.9%，少阳阳明合病证 7 例，占 11.3%，太阴少阴合病证 6 例，占 9.7%，太阳阳明合病证 4 例，占 6.5%，阳明证类 3 例，占 4.8%，厥阴证类 3 例，占 4.8%，太阳证类 1 例，占 1.6%，少阳证类 1 例，占 1.6%。本研究中少阳阳明病证占比最多，以合病证为主，单经占比相对较少，提示慢性荨麻疹临床病机复杂，以合病证常见。

4.5 小结

综上所述，本研究发现青中年为慢性荨麻疹的好发人群，女性患者占比较男性患者更大，病程在 1 年以内的患者人数占比最大。在 8 周观察周期中，经六经辨证予以中药处方治疗慢性荨麻疹的疗效优于西医传统抗组胺治疗，六经辨证治疗慢性荨麻疹有确切疗效，安全性良好，能够显著改善患者风团、瘙痒等临床症状，本研究明确了传统中医药治疗慢性荨麻疹的疗效与优势，为六经辨证治疗慢性荨麻疹的临床疗效与安全性提供了有效依据。

4.6 不足与展望

本研究探讨了六经辨证治疗慢性荨麻疹的临床疗效与安全性，将真实世界的经验转化为真实世界的证据，为传统药方治疗慢性荨麻疹的临床疗效提供了更有力的证据。但本研究样本量较小，研究结果可能存在地域限制，所得结论有待进一步验证。且慢性荨麻疹患者病程较长，本研究观察周期为 8 周，随访周期较短，未来可进一步延长观察周期及随访周期，以观察远期临床疗效。

全文总结

本研究共纳入符合纳排标准的慢性荨麻疹患者 126 例，探讨了六经辨证治疗慢性荨麻疹的疗效与安全性，得出以下结果：

1. 本研究收集 126 例慢性荨麻疹患者, 其中女性 87 人, 男性 39 人, 分别占比 69.0%, 31.0%, 男女比率为 1:2.2, 可见慢性荨麻疹患者中女性患者占比较男性患者更大。

2. 受试者中未成年人 8 人 (<18 岁), 占 6.35%, 青年人 76 人 (18~44 岁), 占 60.32%, 中年人 34 人 (45~59 岁), 占 26.98%, 老年人 8 人 (>60 岁), 占 6.35%, 其中最年轻为 12 岁, 最大年龄 71 岁, 平均年龄 38.4 岁, 表明青中年人群为慢性荨麻疹好发人群。

3. 病程 <1 年的患者有 72 例, 占 57.14%, 1-5 年 37 例, 占 29.37%, 5-10 年 13 例, 占 10.32%, >10 年 4 例, 占 3.17%, 其中病程在 1 年以内的患者人数超过总数的 1/2, 占比最大, 病程超过 10 年的患者人数最少。

4. 依据六经辨证施治, 在 62 例患者中, 少阳太阴合病证 29 例, 占 46.8%, 太阳太阴合病证 8 例, 占 12.9%, 少阳阳明合病证 7 例, 占 11.3%, 太阴少阴合病证 6 例, 占 9.7%, 太阳阳明合病证 4 例, 占 6.5%, 阳明证类 3 例, 占 4.8%, 厥阴证类 3 例, 占 4.8%, 太阳证类 1 例, 占 1.6%, 少阳证类 1 例, 占 1.6%。本研究中少阳阳明病证占比最多, 以合病证为主, 单经占比相对较少。

5. 在 8 周观察周期中, 经过对治疗前后慢性荨麻疹患者活动程度评分 (UAS-7) 的评估, 治疗组总有效率 87.10%, 对照组总有效率 71.88%, 治疗组经治疗后疗效优于对照组, 经六经辨证予以中药处方治疗慢性荨麻疹的疗效优于西医传统抗组胺治疗, 六经辨证治疗慢性荨麻疹有确切疗效, 安全性良好, 能够显著改善患者风团、瘙痒等临床症状, 本研究明确了传统中医药治疗慢性荨麻疹的疗效与优势, 为六经辨证治疗慢性荨麻疹的临床疗效与安全性提供了有效依据。

6. 安全性评价: 治疗组中 1 例患者在用药过程中出现腹泻情况, 调整中药处方后腹泻症状消失, 余患者未见明显异常, 两组受试者用药安全性均良好。

参考文献

- [1]中国荨麻疹诊疗指南(2018 版)[J].中华皮肤科杂志,2019(01):1-5.
- [2]Zuberbier T et al. The international EAACI/GA² LEN/Euro GuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. ALLERGY. 2022-03-01;77(3):734-766.
- [3]Gonçalo M, Giménez-Arnau A, Al-Ahmad M, Ben-Shoshan M, Bernstein JA, Ensina LF, Fomina D, Galván CA, Godse K, Grattan C, Hide M, Katelaris CH, Khoshkhui M, Kocatürk E, Kulthanan K, Medina I, Nasr I, Peter J, Staubach P, Wang L, Weller K, Maurer M. The global burden of chronic urticaria for the patient and society. Br J Dermatol. 2021 Feb;184(2):226-236.
- [4]张苍,李伯华,王乐,蓝海冰,张丰川,段行武,华华,白彦萍,李元文,刘瓦利,瞿幸.论慢性荨麻疹的中医核心病机与辨治思路[J].北京中医药,2019,38(05):403-406.
- [5] Sherman RE, Anderson SA, Dal Pan GJ, et al. Real-world evidence--What is it and what can it tell us?[J]. N Engl J Med, 2016, 375(23): 2293- 2297.
- [6]李金根,姜众会,高铸焘,徐浩.真实世界研究在中医药临床研究中的应用[J].世界科学技术-中医药现代化,2017,19(01):78-82.
- [7]中国荨麻疹诊疗指南(2018 版)[J].中华皮肤科杂志,2019(01):1-5.
- [8]赵辨.中国临床皮肤病学[M],南京:江苏科学技术出版社,2010:742-748.
- [9]陈红风.中医外科学[M],北京:中国中医药出版社,2021,11 版:181-183.
- [10]刘续宝,王素萍.临床流行病学与循证医学.第4版[M].人民卫生出版社,2013.
- [11]冯世纶,张长恩.解读张仲景医学经方六经类方证[M],北京:人民军医出版社,2011,2 版:181-183.
- [12]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药出版社,2002.
- [13] Sherman RE, Anderson SA, Dal Pan GJ, et al. Real-world evidence--What is it and what can it tell us?[J]. N Engl J Med, 2016, 375(23): 2293- 2297.
- [14] Kaplan NM, Sproul LE, Mulcahy WS. Large prospective study of ramipril in patients with hypertension. CARE Investigators[J]. Clin Ther, 1993, 15(5): 810-818.

- [15]杨松,马龙腾,张菁菁.中国临床医学真实世界研究施行规范[J].解放军医学杂志,2018,43(01):1-6.
- [16]李金根,姜众会,高铸烨,徐浩.真实世界研究在中医药临床研究中的应用[J].世界科学技术-中医药现代化,2017,19(01):78-82.
- [17]陈吉,孙月,布优祥,田金徽.中医领域真实世界研究现状分析[J].中国循证医学杂志,2018,18(11):1216-1223.
- [18]张苍,李伯华,王乐,蓝海冰,张丰川,段行武,华华,白彦萍,李元文,刘瓦利,瞿幸.论慢性荨麻疹的中医核心病机与辨治思路[J].北京中医药,2019,38(05):403-406.
- [19].瘾疹(荨麻疹)中医治疗专家共识[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2017,16(03):274-275.
- [20]张大萍.张作舟老中医治疗慢性荨麻疹经验介绍[J].新中医,2013,45(07):200-201.
- [21]杨洁,刘琪,王艳君,薛维华.从脏腑论治慢性荨麻疹研究概述[J].山东中医药杂志,2021,40(01):100-104.
- [22]熊兴江,李海霞.皮肤病经方方证对应论治体悟[J].中华中医药杂志,2011,26(02):297-299.
- [23]欧阳卫权.伤寒论六经辨证与方证新探——经方辨治皮肤病心法[M].北京:中国中医药出版社,2013,1版:34.
- [24]冯世纶,张长恩.解读张仲景医学经方六经类方证[M],北京:人民军医出版社,2011,2版:51.
- [25]陈明,刘渡舟伤寒临证指要[M],北京:学苑出版社,1998:23.
- [26]欧阳卫权.伤寒论六经辨证与方证新探——经方辨治皮肤病心法[M].北京:中国中医药出版社,2013,1版:29.
- [27]李朝辉,刘艳芝.加减麻黄汤治疗急性荨麻疹126例[J].山东中医杂志,2010,29(06):386-387.
- [28]王红军.自拟加味麻黄汤治疗寒冷性荨麻疹30例[J].皮肤病与性病,2004(01):18.
- [29]周昶.桂枝汤加减联合枸地氯雷他定治疗慢性特发性荨麻疹的临床效果[J].实用临床医学,2020,21(11):14-15+18.
- [30]韩洁茹,常佳怡,解颖,孟璐,姜德友.桂枝麻黄各半汤加味联合西替利嗪治疗寒

- 冷性荨麻疹 60 例临床观察[J].世界中西医结合杂志,2019,14(07):902-905.
- [31]江丽莹,顾民华,陈惠娟,洪文.麻杏石甘汤加减治疗风热犯表证慢性荨麻疹 80 例临床观察[J].山西中医学院学报,2015,16(03):49-50.
- [32]刘金荣.调胃承气汤合白虎汤治疗荨麻疹 72 例[C]. 内蒙古自治区中蒙医研究所、全国中医药信息工作委员会.第四届全国民族医药学术交流暨《中国民族医药杂志》创刊 10 周年庆典大会论文集.内蒙古自治区中蒙医研究所、全国中医药信息工作委员会:《中国民族医药杂志》编辑部,2005:162.
- [33]赵文斌,马雪婷,鹿见香,赵慧忠,白彦萍.小承气汤加减治疗瘾疹举隅[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2013,12(02):133.
- [34]李腾龙,孙邦梅.小柴胡汤加减结合刺络拔罐治疗急性荨麻疹伴发热临床疗效观察[J].湖北中医药大学学报,2021,23(02):79-81.
- [35]陈谦峰,谢斌.大柴胡汤古方新用举隅[J].光明中医,2017,32(10):1496-1497.
- [36]尹云斌. 黄芪建中汤加味治疗脾胃虚寒型慢性荨麻疹疗效观察[D].山东中医药大学,2016.
- [37]刘亭亭,耿立东.桂附理中汤加味治疗寒冷性荨麻疹疗效观察[J].山西中医,2015,31(11):45.
- [38]徐俊涛,王莹,王丽,刘爱民,方玉甫.麻黄附子细辛汤联合依巴斯汀治疗脾虚湿蕴证慢性自发性荨麻疹的临床疗效及安全性分析[J].中国全科医学,2019,22(S2):142-145.
- [39]肖月园,王刚.临床治愈 198 例慢性荨麻疹的中医证候、用方体会及远期疗效分析[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2016,15(06):340-344.
- [40]陈芒华,谢俊宇,卢敏.浅谈经方黄连阿胶汤临床运用的心得体会[J].中医临床研究,2019,11(10):32-33.
- [41]张军斌. 基于“六经欲解时”理论以乌梅丸治疗慢性荨麻疹疗效观察[D].山东中医药大学,2019.
- [42]郝万山.柴桂温胆定志汤为主治疗精神抑郁症[J].北京中医药大学学报,1997(03):64-65.

文献综述

慢性荨麻疹的中西医研究进展

慢性荨麻疹(chronic urticarial, CU)属于中医“瘾疹”范畴,古代又称“风疹”、“游风”、“鬼风疙瘩”等,是皮肤科常见的变态反应性疾病。中医认为本病的发生,是外有六淫邪气单独或兼夹致病,内有禀赋不足、脏腑寒热虚实失调,内外合病。治疗上,医家除采用六经辨证、脏腑辨证等辨证方法予以患者中药口服外,针灸、穴位埋线、自血疗法等中医外治法也得到了广泛地应用。而西医认为荨麻疹(urticaria)多以风团伴瘙痒为主要临床表现,是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应,皮损反复发作,每周发作 ≥ 2 次,且连续发作 >6 周者为慢性荨麻疹(chronic urticarial, CU)^[1]。荨麻疹病情严重者可伴有喉梗、腹痛、等全身症状。临床上常选用第二代抗组胺药物作为一线治疗方案,而经抗组胺治疗后患者症状不能控制时,可考虑选用雷公藤多苷片、环孢素、生物制剂等药物,病情急性加重可考虑短期试用糖皮质激素。荨麻疹作为临床常见的皮肤疾病之一,其发病机制目前尚不明确,临床上常反复发作、迁延难愈,严重影响患者的生活质量和心理健康。近年来国内外学者对其危险因素、发病机制,生物制剂等多方面都有较多探索。现就该病的中西医研究进展综述如下。

1 病因病机

中医学认为风、寒、湿邪等外感六淫均可导致本病的发生,而风善行而数变,为百病之长,强调风邪是荨麻疹发病的核心病机。《素问》云:“风邪客于肌中肌虚,真气致散……淫气行之则痒也”,风为阳邪,伤人卫气,风性开泄,腠理不固,复感寒邪,风寒相搏,郁于肌肤,而致瘾疹。《诸病源候论》认为本病是因风寒湿热等邪气相互搏结肌肤所致。《金匱要略》:“风气相搏,风强则为瘾疹”。除风邪致病外,表虚不固、脏腑失调也是荨麻疹发病的关键因素,如《诸病源候论》言“人皮肤虚,为风邪所折,则起瘾疹。”提出了本病是因表虚不固,风邪侵犯人体所导致。《幼幼集成》、《赤水玄珠》等认为瘾疹的发病多责之于脾。而《三因极一病证方论》则认为风寒暑湿邪气,脏腑的虚实寒热,都可以导

致本病的发生,而非风邪单独致病。“诸痛痒疮皆属于心”,《医宗金鉴》认为内有心火亢盛,实则克其所胜,火灼肺金,外兼感风湿之邪而生瘾疹,亦认为本病病因不仅与风邪有关,脏腑的虚实也可以导致发病。现代中医,如张苍^[2]等多位专家不仅强调风邪是慢性荨麻疹的核心病机,认为风有内外、经络、脏腑之别,而且认为风邪入络、寒热并存、虚实兼夹、阴阳并见是荨麻疹顽固化的重要原因。综上所述,风邪是荨麻疹发病的核心病机,表虚不固、脏腑气血阴阳的失调,多种病理因素兼夹存在,是其迁延难愈的重要因素。

西医学认为荨麻疹的诱因包括物理因素(如冷、热、运动、日光等),食物、食品添加剂、药物、感染、慢性疾病(如甲状腺疾病、炎症性肠病等)、精神因素等^[3]。慢性荨麻疹病因复杂,临床上多难以明确,许多学者也试图从临床研究中分析和找出其危险因素,如 Khoshkhui M^[4]提出维生素 D 受体基因 Taq1 基因型多态性可能是慢性自发性荨麻疹的危险因素。Li Y^[5]等通过进行最新的荟萃分析以综合新发现,认为 VitD 补充剂可以减少荨麻疹的临床症状。从发病机制上看,肥大细胞的诱导活化是荨麻疹发病的关键,嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、B 细胞和 T 细胞也被认为参与了本病的发病。肥大细胞活化脱颗粒,组胺、细胞因子、炎症因子等引起血管扩张及通透性增加,导致了荨麻疹的产生^[1]。临床常见的是肥大细胞脱落后激发机体的激活模式的 I 型变态反应^[6]。经典的 I 型变态反应为过敏原刺激身体产生 IgE,其 Fc 段结合嗜碱性粒细胞和肥大细胞膜表面受体,使机体产生变应。当变应原第二次进入体内并与特异性 IgE 抗体结合时,肥大细胞进行脱颗粒,释放产生组胺等血管活性物质,导致皮肤小血管扩张,血浆渗透性加强,最后形成局部或全身产生一系列过敏反应^[7]。近年来许多学者对慢性荨麻疹的发病机制也多有探索,如 Sauer M^[8]等根据 IgA 和 IgE 水平将 606 名 CSU 患者分为四组,分析了他们的数据,比较这些组的症状谱、疾病活动、伴随的自身免疫和常规实验室标志物。结果提示在 IgE 水平较低的患者中,66.5%的患者 IgA 水平也较低,IgA 和 IgE 水平较低的患者显示复发性血管性水肿和伴随自身免疫的患病率较高。认为 CSU 中较低的 IgA 水平与较低的 IgE 水平和自身免疫性荨麻疹的特征有关。程永好^[9]等通过观察 46 例慢性荨麻疹患者及 46 例健康人治疗前后 D-二聚体、IgE 抗体和 Fc ϵ RI 水平变化,且观察组指标水平治疗前后均高于对照组,认为 D-二聚体、IgE 抗体和 Fc ϵ RI 水平变化对慢性荨麻疹的诊断具

有价值。Obtułowicz A^[10]等纳入 142 名诊断为 CSU 的患者，使用 UAS-7（荨麻疹活动评分）评估荨麻疹的活动，并根据 UAS-7 荨麻疹活动评分分为 4 组，进行 ASST 检测并收集血液以确定生物标志物（CRP、维生素 D、D-二聚体、纤维蛋白原、MPV、PLT），得出凝血和纤溶途径以及维生素 D 可能参与荨麻疹的发病机制。由此提示我们，IgA、凝血机制的异常等也可能参与了慢性荨麻疹的发病。

2 中医治疗方法

慢性荨麻疹的中医治疗分为中医内治和中医外治两种形式。

2.1 中医内治

本病目前在中医辨证分型上尚不统一。《中医外科学》将荨麻疹分为 4 个证型，即风寒束表证、风热犯表证、胃肠湿热证、血虚风燥证。辨证论治以疏风为核心，以麻桂各半汤疏风解表、散寒止痒，消风散疏风解表、清热止痒，防风通圣散外解风邪、内泄腑热，当归饮子祛风止痒、养血润燥。2017 年荨麻疹中医治疗专家共识将本病分为 5 个证型，风热证以银翘散或消风散加减，风寒证以麻桂各半汤或荆防败毒散加减，肠胃湿热证以防风通圣散或除湿胃苓汤加减，毒热炽盛证以犀角地黄汤合黄连解毒汤加减，气血亏虚证以八珍汤合玉屏风散或当归饮子加减^[11]。张作舟老中医将荨麻疹分为表虚不固、血虚气弱、阴虚内热和湿热内蕴 4 种类型，治以固卫和营、佐以酸敛，养血熄风、内外同治，滋阴清热、潜阳熄风，清热理脾、宣化湿浊等，临床取得较好疗效^[12]。杨洁^[13]等通过整理有关慢性荨麻疹从心、肝、脾、肺、肾及多脏腑论治的相关研究，认为当前多数医家已认识到脏腑辨证在慢性荨麻疹诊治过程中的重要性，从脏腑论治可达到调整阴阳、除病祛邪的目的。熊兴江^[14]等认为经方是在方证对应原则指导下，从整体出发，针对患者症状及体征用药。作者运用柴胡桂枝汤、桂枝汤、麻黄连翘赤小豆汤等治疗慢性荨麻疹，均取得一定疗效。从上述内容我们可以得出，临床上慢性荨麻疹患者的症状多样、病机复杂，往往多种证候相互兼夹，传统单一的证型难以一一对应。中医关于慢性荨麻疹的辨证方式多样，常运用病因辨证、气血辨证、脏腑辨证、六经辨证等辨证方法。

2.2 中医外治法

除了内服中药外，慢性荨麻疹还有许多外治疗法，如针灸、穴位埋线、自血疗法、穴位贴敷、中药熏蒸、脐疗、刺络拔罐、耳穴等。基于中医的整体观，经

络沟通内外，使皮肤、官窍、肌肉、筋骨、脏腑形成一个有机的整体，“有诸形于内，必形于外”，荨麻疹多发于皮肤，故外治法可直达病所从而发挥局部甚至整体的治疗作用，而中医外治法大都操作简单、方法灵活、刺激性小、疗效显著，具有其独特的优势^[15]。

3 西医疗疗

3.1 对因治疗

针对荨麻疹患者病因的治疗是荨麻疹重要的治疗方式，如不能做到根除病因时，应尽量减少促进荨麻疹发病的诱因，具体应从以下几方面考虑：①对诱导性荨麻疹患者，应有效避免相应的诱因，如人工荨麻疹应避免用力摩擦、抓挠皮肤，冷接触性荨麻疹应避免暴露在低温环境下，避免接触冷水、冰块等，热接触性荨麻疹应避免接触高温物品，延迟压力性荨麻疹应穿戴宽松舒适的衣物，日光性荨麻疹应减少日晒，振动性荨麻疹应避免产生振动的操作，胆碱能性荨麻疹应避免剧烈运动，水源性荨麻疹应避免直接接触水，接触性荨麻疹应避免对可能导致过敏的物质直接接触^[16]；②当怀疑是药物诱导的荨麻疹时，可根据患者病情考虑停止服用该药物，或选择其他药物替代；③对怀疑食物诱发荨麻疹的患者，应积极寻找食物过敏原，避免食用相关食物；④当其他治疗疗效欠佳或无效，怀疑慢性荨麻疹发病与感染、慢性疾病相关时，可考虑予以抗感染或相关疾病的治疗；⑤对自体血清皮肤试验阳性或证实体内存在针对 Fc ϵ RIa 链或 IgE 自身抗体的患者，常规治疗无效且病情严重时可酌情考虑加用免疫抑制剂、自体血清注射治疗或血浆置换等^[3]。

3.2 药物治疗

第二代抗组胺药为轻中度慢性荨麻疹的一线治疗药物^[3]。常规剂量的抗组胺药物治疗无效时，可考虑加量或者更换不同种类的抗组胺药或者联合不同的抗组胺药物使用。若联合使用 2 种及以上抗组胺药物或使用增量抗组胺药物，而症状仍未缓解的慢性荨麻疹患者，可以考虑添加使用奥马珠单抗或雷公藤多苷片、环孢素等，病情急性加重期可考虑短期应用糖皮质激素治疗。关于荨麻疹的治疗，近年来生物制剂的应用如奥马珠单抗的疗效、安全性、复发率等多方面的研究，成为了国内外学者研究的热点问题。有学者如 Ornek S^[17]等回顾性分析了 41 名接受奥马珠单抗治疗至少 3 年的 CSU 患者的人口统计学特征、临床特征、实验室

参数和治疗结果。结果显示 9 名患者 (22%) 对 300 毫克/4 周的奥马珠单抗反应不足, 需要加药。38 名患者(92.7%)可以耐受更长的给药间隔 (> 4 周), 平均注射 11.53 次后, 给药间隔增加, 奥马珠单抗的疗效没有丧失。16 名患者(39%) 在平均停药时间为 24 周后再次接受奥马珠单抗治疗。五名患者(12.2%) 报告了轻微和短暂的不良反应。奥马珠单抗前后的肝肾功能检查以及全血细胞计数均在正常范围内。认为对于 CSU 的长期管理, 奥马珠单抗是一种安全有效的治疗方法, 可以根据患者的疾病活动度进行定制。Altunisik E^[18]等选择了 47 名接受奥马珠单抗治疗的 CSU 患者, 在治疗前和奥马珠单抗治疗后三个月进行神经学检查后进行电生理测量, 结果提示奥马珠单抗对周围神经没有影响, 无论是从周围神经还是神经结构来看, 都是一种安全且耐受性好的药物。

4 结语

慢性荨麻疹属于中医“瘾疹”范畴, 中医认为风邪是荨麻疹发病的核心病机, 表虚不固、脏腑气血阴阳的失调, 多种病理因素兼夹存在, 是导致荨麻疹缠绵难愈的重要因素。治疗上除采用病因辨证、气血辨证、脏腑辨证、六经辨证等辨证方法予以中药内治外, 针灸、穴位埋线、自血疗法、穴位贴敷等中医外治疗法也具有其独特优势。西医认为根除或减少荨麻疹发病的诱因是治疗慢性荨麻疹的重要方式。治疗上多采用抗组胺药物、免疫抑制剂、糖皮质激素、生物制剂、自体血清注射治疗、血浆置换等。慢性荨麻疹临床上常反复发作、迁延难愈, 严重影响患者的生活质量和心理健康。中医治疗、西医治疗都各有所长, 临床上不应拘泥于单种治疗方式, 对患者的情况区别对待, 扩展思路, 以取得最佳的治疗效果。

参考文献

- [1]赵辩.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2017: 783-785.
- [2]张苍,李伯华,王乐,蓝海冰,张丰川,段行武,华华,白彦萍,李元文,刘瓦利,瞿幸.论慢性荨麻疹的中医核心病机与辨治思路[J].北京中医药,2019,38(05):403-406.
- [3]中国荨麻疹诊疗指南(2018 版)[J].中华皮肤科杂志,2019(01):1-5.
- [4]Khoshkhui M, Iravani F, Jabbari-Azad F, Zare Marzouni H, Tavakkol-Afshari J, Zamani H, Davarpanah M, Hamidian Jahromi A, Mohammadi M. Significant association between Taq1 gene polymorphism in vitamin D receptor and chronic spontaneous urticaria in the Northeast of Iran. Clin Mol Allergy. 2021 May 27;19(1):6.
- [5]Li Y, Cao Z, Guo J, Li Q, Su J. Effects of Serum Vitamin D Levels and Vitamin D Supplementation on Urticaria: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021 May 5;18(9):4911.
- [6]袁睿.慢性荨麻疹的发病机制及治疗进展[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(32):40-41.
- [7]张学军.皮肤性病学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2007.107-110.
- [8]Sauer M, Scheffel J, Frischbutter S, Kolkhir P, Xiang YK, Siebenhaar F, Altrichter S, Maurer M, Metz M, Krause K. Lower IgA Levels in Chronic Spontaneous Urticaria Are Associated With Lower IgE Levels and Autoimmunity. Front Immunol. 2021 May 3;12:657211.
- [9]程永好,班懋洁,贺娟,李新新.D-二聚体、过敏原特异性 IgE 抗体和受体检测对慢性荨麻疹诊断及预后价值分析[J].中国医学工程,2021,29(05):114-116.
- [10]Obtułowicz A, Migacz-Gruszka K, Pirowska M, Basta-Klonowska K, Wojas-Pelc A. Participation of the coagulation system and fibrinolysis as well as selected biomarkers in pathogenesis of chronic urticaria with various activity degree. Postepy Dermatol Alergol. 2020 Aug;37(4):608-612.
- [11].瘾疹(荨麻疹)中医治疗专家共识[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2017,16(03):274-275.

- [12] 张大萍. 张作舟老中医治疗慢性荨麻疹经验介绍 [J]. 新中医, 2013, 45(07): 200-201.
- [13] 杨洁, 刘琪, 王艳君, 薛维华. 从脏腑论治慢性荨麻疹研究概述 [J]. 山东中医药志, 2021, 40(01): 100-104.
- [14] 熊兴江, 李海霞. 皮肤病经方方证对应论治体悟 [J]. 中华中医药杂志, 2011, 26(02): 297-299.
- [15] 屈婷婷, 李中平, 熊蓉, 谌莉媚. 中医外治慢性荨麻疹的研究进展 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17(95): 53-55.
- [16] 中华医学会皮肤性病学分会免疫学组. 中国慢性诱导性荨麻疹诊治专家共识 (2023) [J]. 中华皮肤科杂志, 2023, e20220819.
- [17] Ornek S, Kocaturk E. A patient-oriented approach to long-term use of omalizumab in chronic spontaneous urticaria. Cutan Ocul Toxicol. 2021 Jul 2;1-7.
- [18] Altunisik E, Inan Dogan E. Effect of omalizumab treatment on peripheral nerves in patients with chronic spontaneous urticaria. Cutan Ocul Toxicol. 2021 Jun;40(2):130-134.

附录

附录一

中医四诊资料收集单

姓名:	性别:	出生年月:	发病时间:	就诊时间:	病名:		
项目	太阳	阳明	少阳	太阴	少阴	厥阴	其他
寒热	怕风 ☐ 易感冒 ☐	怕热 ☐	四肢冷 ☐		全身怕冷 ☐		
汗			头颈汗 ☐ 手足汗 ☐				
头	头痛 (头后部) ☐	头痛 (前额、眉棱骨) ☐	头痛 (两侧) ☐	头晕 ☐			
眼睛			痒 ☐				
咽			咽痒 ☐ 异物感 ☐	有痰 ☐			
口		口臭 ☐	口苦 ☐	口淡 ☐		口腔溃痛 ☐	
胸			乳房胀痛 ☐				
胃口		多食易饥 ☐	恶心反胃 ☐	不饿少食 ☐ 吐清水 ☐			
心下						痞满 ☐	
腰					酸 ☐		
腹				食后作胀 ☐			
关节	疼痛 ☐						
睡眠			易惊醒 ☐	多梦 ☐	难入睡 ☐		
饮水		渴喜饮水 ☐		不渴 ☐			
大便		干 ☐		稀 ☐			
小便				饮则多尿 ☐	夜尿 ☐		
白带		黄臭 ☐		清稀量多 ☐			
情绪			多言善动 ☐ 易怒 ☐		淡漠 ☐		
精神				困乏 ☐	疲倦 ☐		
月经	血热: 先期、量多、色鲜红 ☐			血虚: 痛经、量少 ☐			
舌							
脉							

附录二

荨麻疹活动程度评分量表 (UAS-7)

症状	风团评分				瘙痒评分				总分	治疗
程度	没有 无风团	轻微 风团小于 20 个 /24 小时	中度 风团在 20-50 个/24 小时	严重 风团大于 50 个 /24 小时或大面 积风团	没有 无瘙痒	轻微 有瘙痒, 不明显	中度 明显瘙痒, 但尚 不影响日常生活 或睡眠	严重 严重瘙痒, 不能 忍受, 严重困扰 日常生活或睡眠		
第 1 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		
第 2 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		
第 3 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		
第 4 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		
第 5 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		
第 6 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		
第 7 日 月 日	0	1	2	3	0	1	2	3		